

A. Savoir reconnaître un hémothorax et un pneumothorax sur une radiographie

A. Radiographies d'hémothorax et de pneumothorax

Radiographies de thorax de face (2 patients distincts)

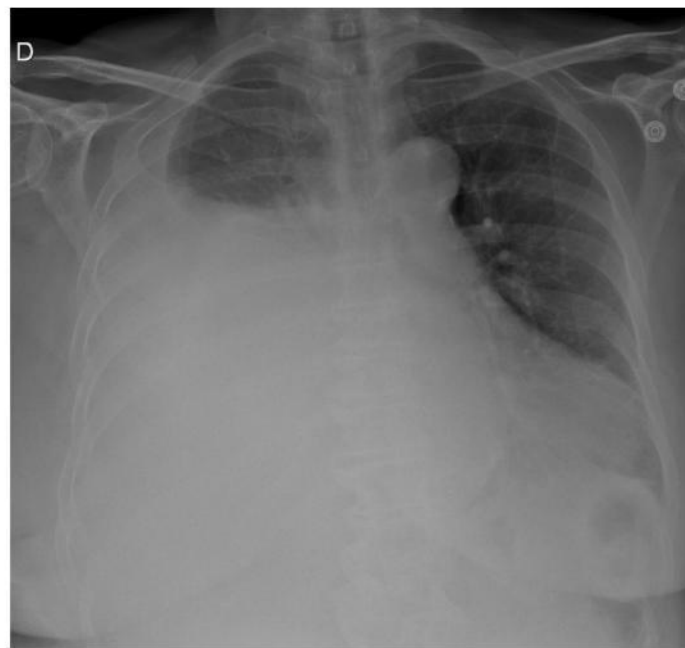


Pneumothorax complet gauche

Sémiologie classique du pneumothorax non traumatique et de l'épanchement liquidien non hémattique, fractures de côtes parfois visibles (pas ici)



Voir items
207/360 et
206/207



Hémothorax droit

B. Connaître la séméiologie radiologique de base des fractures diaphysaires simples des os longs

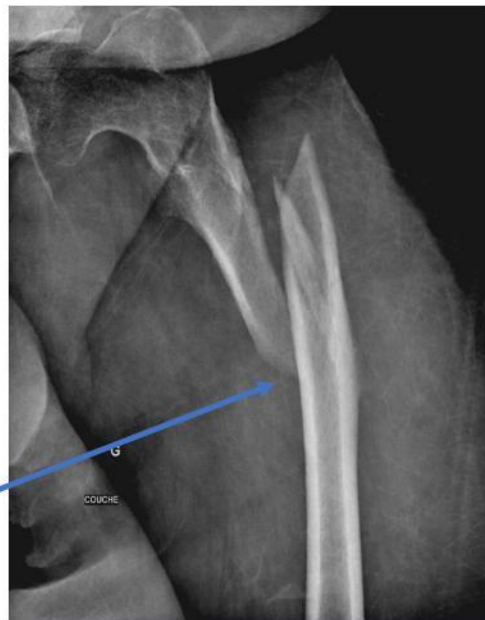
B. Identifier une fracture diaphysaire des os longs

Description de la fracture

1. **Identification de l'os atteint et du côté**
2. **Précision sur le siège diaphysaire atteint** (tiers supérieur, moyen, inférieur)
3. **Description du trait de fracture** : simple (transversal, oblique, spiroïde) ou complexe (fracture comminutive)
4. **Existence d'une atteinte articulaire**
5. **Existence d'un déplacement et type** : angulation, chevauchement, translation

Trait de fracture oblique avec déplacement majeur du tiers supérieur du fémur responsable d'une perte de contact entre les deux fragments osseux

Radiographie du fémur gauche de face



Fracture déplacée du tiers supérieur de la diaphyse du fémur gauche

B. Exemple TDM d'hématome extra-dural, sous-dural et contusions cérébrales

TDM du crâne sans injection, coupes axiales, fenêtre parenchymateuse (deux patients distincts)

Collection péri-cérébrale droite en croissant, dépassant les sutures osseuses (donc sous-durale), hyperdense (donc saignement aigu)

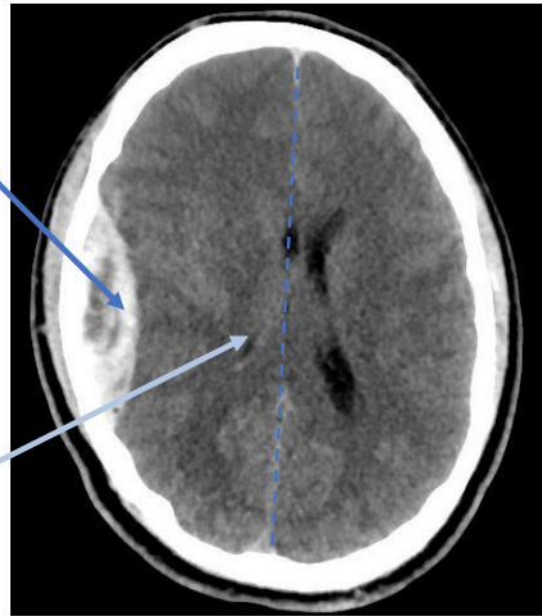


HSD droit avec effet de masse et engagement

Collection péri-cérébrale droite en lentille biconvexe, ne dépassant pas les sutures osseuses (donc extra-durale), hyperdense (donc saignement aigu)

Effacement partiel du ventricule latéral droit et déviation de la ligne médiane (représentée en pointillé) témoignant d'un effet de masse et d'un engagement sous-falcoriel. Effacement des sillons, témoignant de l'HTIC

HSD : hématome sous-dural
HED : hématome extra-dural
HTIC : hypertension intracrânienne



HED droit avec effet de masse et engagement



Voir item
57

B. Scanner d'une fracture de mandibule (coupes ou reconstruction)

TDM du massif facial, coupe coronale, fenêtre osseuse



Trait de fracture horizontal sans déplacement de la branche gauche de la mandibule

Fracture de la mandibule gauche

B. Scanner d'une fracture du plancher de l'orbite

TDM du massif facial, coupe coronale, fenêtre osseuse



Trait de fracture avec déplacement du plancher de l'orbite droite

TDM du massif facial, coupe axiale, fenêtre tissus mous (même patient)



Hyperdensité spontanée au sein du sinus maxillaire droit : hém sinus associé

Fracture du plancher de l'orbite droite

TDM cérébrale sans injection, coupes axiales, fenêtre parenchymateuse (2 patients distincts)

Hyperdensités spontanées au sein des vallées sylviennes

Hyperdensité spontanée de la citerne inter-pédonculaire

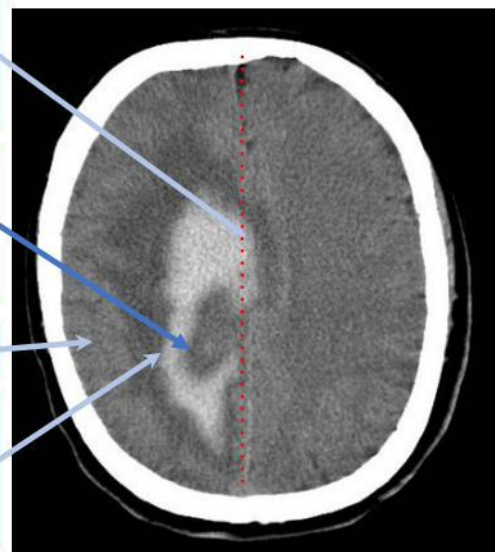


Déviation de la ligne médiane témoignant d'un engagement sous-falcien

Hyperdensité spontanée : hématome de l'hémisphère droit

Effacement des sillons

Hypodensité mal limitée entourant l'hyperdensité : Œdème péri-lésionnel



Voir item
340

Hémorragie sous-arachnoïdienne

Hématome profond hémisphérique droit
responsable d'un effet de masse

B. Reconnaître un effet de masse et un engagement cérébral sur le TDM

TDM cérébrale sans injection, coupe axiale, fenêtre parenchymateuse

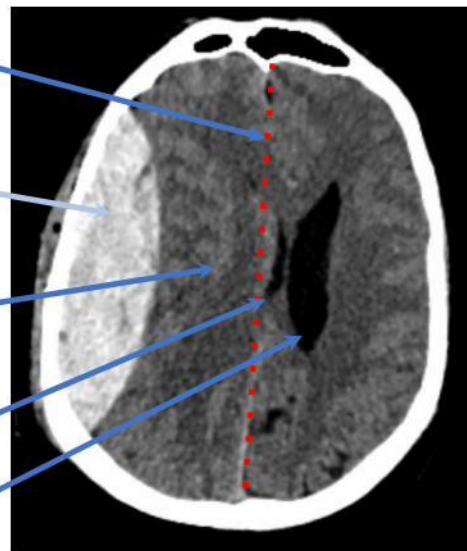
Déviation de la ligne médiane (pointillé rouge) témoignant d'un engagement sous-falcoriel

Hématome de forme biconvexe :
hématome extra-dural

Effacement des sillons
Refoulement de l'hémisphère droit

Aspect collabé du ventricule latéral droit

Dilatation du ventricule latéral gauche



Hématome extra-dural droit
responsable d'un effet de masse

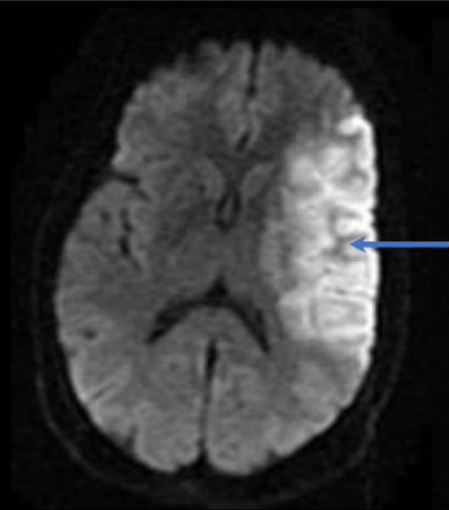


Voir item 57

B. Exemple d'AVC ischémique en phase aiguë en IRM

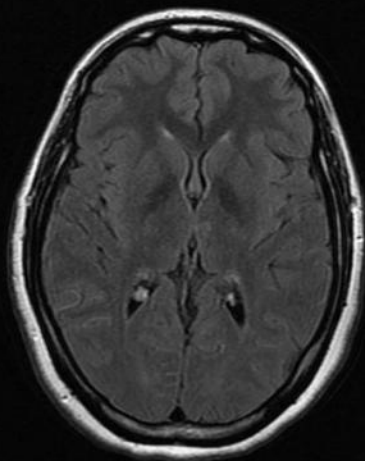
Séquence de diffusion : la plus précocement positive

Séquence de diffusion



Hypersignal diffusion (restriction de la diffusion) systématisé du territoire cérébral moyen gauche

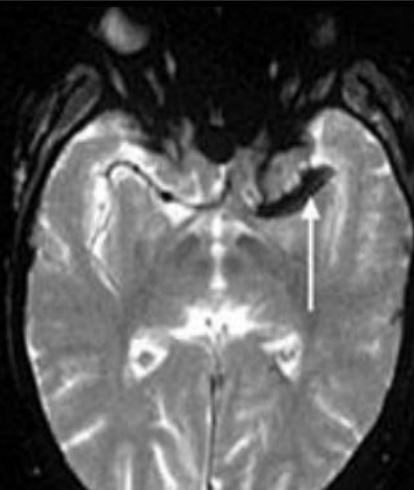
Séquence FLAIR



Absence d'anomalie de signal FLAIR = caractère aigu de l'infarctus

IRM cérébrale

Séquence T2*



Thrombus dans l'artère cérébrale moyenne gauche en hyposignal T2*

AngioIRM TOF



Défaut de flux au sein de l'artère cérébrale moyenne gauche

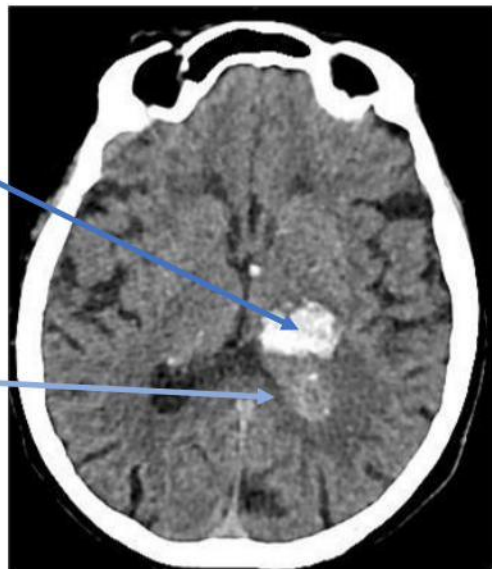
AVC ischémique aigu du territoire cérébral moyen gauche

B. Exemple d'AVC hémorragique profond en phase aiguë en TDM

TDM cérébrale sans injection, coupes axiales (2 patients distincts)

Hyperdensité
spontanée capsulo-
thalamique gauche

Effacement partiel du
ventricule latéral
gauche en regard,
traduisant un effet de
masse



Hématome profond capsulo-thalamique
gauche, avec effet de masse

Hyperdensité
spontanée lobaire
frontale droite

Effacement partiel du
ventricule latéral droit
en regard, traduisant
un effet de masse



Hématome lobaire frontal
droit avec effet de masse

A. Connaître les signes évocateurs d'hémorragie méningée au scanner cérébral sans injection

A. Exemples d'HSA sur TDM

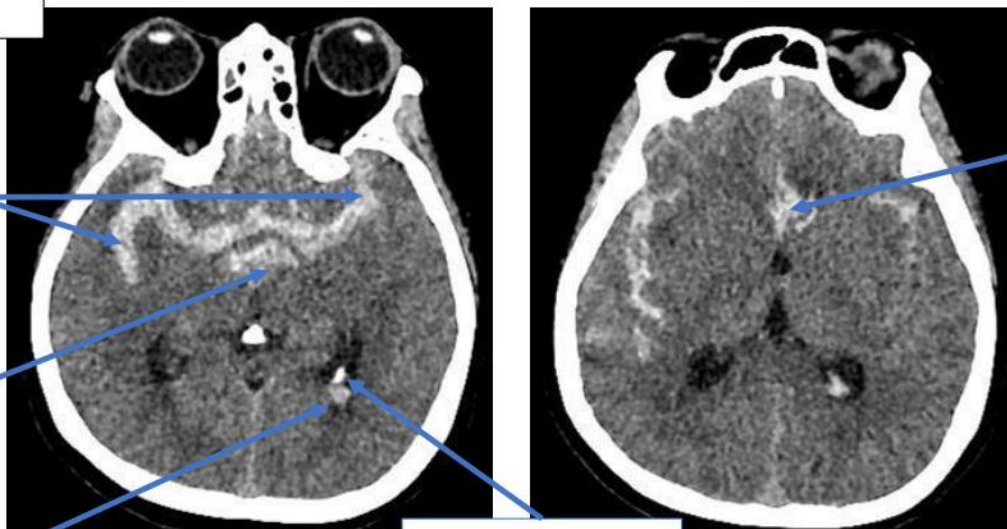
HSA: hyperdensités spontanées (TDM sans injection) dans les espaces sous-arachnoïdiens et citernes de la base

TDM cérébrale sans injection, coupes axiales (*même patient*)

Hyperdensités spontanées au sein des vallées sylviennes

Hyperdensité spontanée de la citerne inter-pédonculaire

Hémorragie intraventriculaire gauche



Hyperdensité spontanée interhémisphérique

Calcification banale du plexus choroïde

Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA)